Зарубежные практики пространственной и транспортной доступности

Это **реальные работающие государственные статистические методики и исследования**, а не утверждение, что другие страны построили точно такой же сайт «МедСвязь 24/7».

1. Великобритания: Transport Connectivity Metric

Исполнитель: Department for Transport, публикация методики 29.09.2025. Измеряется возможность добираться до разных видов деятельности и услуг; используются автомобиль, общественный транспорт, пешие и велосипедные перемещения, время суток, ценность пунктов назначения и транспортные предпочтения. Учитывает, в частности, здравоохранение. Сами показатели показывают **потенциальные возможности поездок, а не реальные потоки**. Прежний ряд Journey Time Statistics прекращён; новый Connectivity Metric — актуальный наследник подхода.

Для нас: заимствовать раздельные слои по виду транспорта, времени суток и целям поездок, но только при наличии расписаний/достоверных данных. Не копировать чужие веса без локального обоснования.

Источник: DfT Transport connectivity metric.

2. Канада: Spatial Access Measures (SAM)

Исполнитель: Statistics Canada. В обновлении 2024 представлены показатели потенциального доступа к объектам по нескольким видам транспорта, включая доступ к медицинским учреждениям с использованием общественного транспорта. Исследование сообщает: в среднем 75,1% населения Канады имеет модельный доступ к учреждениям здравоохранения в течение 90 минут на общественном транспорте в используемой постановке; разброс провинций очень существенный. Это **не результат наших расчётов и не порог качества медицинской помощи**.

Для нас: оценивать охват по времени отдельно от среднего индекса, визуализировать межрегиональное неравенство, разделять виды транспорта и показывать недостаток данных для удалённых территорий.

Источники: Statistics Canada Spatial Access Measures, 2024 Update Report.

3. Австралия: ARIA+ и градации удалённости

Исполнители: Australian Bureau of Statistics, Queensland Government Statistician's Office. ARIA+ измеряет географическую удалённость через дорожные расстояния до населённых сервисных центров разных размеров. Категории включают Major Cities, Inner Regional, Outer Regional, Remote, Very Remote. Методология отражает пространственное неравенство и особенности редкой сети расселения; **не является медицинским рейтингом**.

Для нас: отдельно сравнивать плотные и удалённые территории, визуализировать наихудшие поселения и проверять пограничные/островные связи. Не переносить национальные пороги Австралии напрямую в Россию.

Источники: ABS Remoteness Areas, ARIA+ Queensland.

4. Канада (Онтарио): академическое моделирование охвата больниц

Исследование различий между районами Онтарио сочетало дорожное время, больничную мощность и потенциальный охват населения для стационарной и неотложной помощи. Показана зависимость результатов от вида медицинской услуги и географии. Это исследование, **а не подтверждённая программа строительства новых больниц**.

Для нас: добавить проверенный профиль услуги, мощность больниц и спрос прежде, чем делать инвестиционную рекомендацию о новом объекте.

Источник: PubMed: Geographical disparities in access to hospital care in Ontario.

Сравнительная таблица

Подход	Сильная сторона	Ограничение	Что полезно МедСвязь
DfT, Великобритания	Виды транспорта, цели, время	Сложность данных	Расширенный мультимодальный слой
SAM, Канада	Индикаторы доступа и охвата	Модельное время и доступность расписаний	60/90 мин и географические различия
ARIA+, Австралия	Удалённые территории	Не медицина специально	Анализ малых поселений
Онтарио, исследование	Профиль, мощность больниц	Локальная постановка	Верификация реестра и медфункций

Общий урок: сильная система не просто рисует красные участки, а различает транспортную возможность, реальную доступность услуги, социальный охват и стоимость решений. Её основная ценность — проверяемое сравнение альтернатив при честно указанных ограничениях.